

המועצה המדעית ועדת הבחינות

בחינות שלב א'

רפואת משפחה

30.09.24

מס' השאלות בחלק זה: 100

לנבחן! יש לענות את התשובה הנכונה ביותר

1. בת 50, לוקה בסכרת מזה 6 שנים. מטופלת ב-Metformin פעם ביום.
BMI=38, רמת סוכר בצום 200 mg/dl, רמת HbA1C 7.5%.
בעברה - פנקריאטיטיס, בעקבות כך ניתוח כריתת כיס מרה.
משפחה - אחותה בת 35 מאובחנת כסובלת מ-Multiple Endocrine Neoplasia (MEN)
מהו השינוי התרופתי המתאים ביותר?
א. הוספת Ozempic (Semaglutide).
ב. הוספת Januvia (Sitagliptin).
ג. העלת מינון Metformin X3.
ד. הוספת Novonorm (Repaglinide).
2. בת 36, ללא מחלות רקע, מזה מספר חודשים אירועים חוזרים של כאבים ברום הבטן, מחמירים לאחר ארוחות, בחילות ותחושת שובע מוקדמת. יציאות תקינות, ללא ירידה במשקל.
בבדיקתה הגופנית - רגישות באיזור אפיגסטרי, בדיקות מעבדה: ספירה וכימיה תקינות.
מה השלב הבא בבירור?
א. בדיקת חיידק H.Pylori.
ב. גסטרוסקופיה.
ג. בדיקת Calprotectine.
ד. US בטן עליונה.
3. מטופלת עם תסמונת התעלה הקרפלית (Carpal tunnel syndrome).
באיזה מקרה מומלץ להפנות לטיפול ניתוחי?
א. בת 22, בהריון שבוע 30. תסמיני נימול אופייניים.
ב. בת 55, תסמינים אופייניים מזה 3 שנים. עברה הזרקת סטרואידים עם שיפור ניכר של התסמינים. השיפור נמשך שנה ומאז חלה החמרה.
ג. בת 70, תסמינים מעל 20 שנה. חשה ירידה בתחושה וחולשה באצבעות 1-4, קבוע בכל שעות היום. יש אטרופיה שרירית בבסיס האגודל.
ד. בת 30, תסמיני נימול בלילה מזה חודשיים. בביצוע EMG והולכה עצבית מאורכים במידה קלה.

4. בן 56 מגיע למרפאה עם הופעה חריפה של ראייה מטושטשת וכאבים בעינו הימנית. הוא מצהיר שהוא רואה הילות סביב אורות. אין לו היסטוריה רפואית יוצאת דופן אחרת.
איזה מהבאים הוא המנגנון מאחורי אובדן הראייה החריף של מטופל זה?
א. משקעי דרוזן (Drusen) ברשתית.
ב. עיבוי מקולרי ובצקת.
ג. חסימה בניקוז הנוזלים על ידי הקשתית ההיקפית.
ד. ניוון ואטימות העדשה.
5. בן 9 חודשים, חוסן בחיסוני השגרה עד גיל 4 חודשים. לפני שלושה שבועות סבל מנזלת, גודש אפי ושיעול קל. כעת מזה כשבוע סובל משיעול התקפי טורדני עד כדי הקאה בסוף השיעול. לאחר מכן מרגיש טוב. כעת ללא חום או תסמינים אחרים.
בדיקה גופנית כולל מדדים חיוניים – תקינה.
מהי ההמלצה המתאימה בנוגע לטיפול במחלה שבה אתה חושד?
א. התחלת טיפול אנטיביוטי מוקדם לפני לקיחת דגימה מעבדתית.
ב. מתן טיפול אנטיביוטי מניעתי רק למגעים קרובים שאינם מחוסנים.
ג. במקרים קשים ניתן לטפל ב-IVIG ספציפיים למחלה במסגרת בית חולים.
ד. מתן אינהלציות של Ventolin (Salbutamol) להקלת השיעול.
6. לפניך תיאור של ארבעה מטופלים עם לחץ דם לא מאוזן.
למי מהם הבדיקה המוצעת היא המתאימה ביותר לבירור הסיבה הסבירה למצבו?
א. בן 60, מטופל ב-Tritace comp 5 (Ramipril+Hydrochlorthiazide), לחצי הדם 160/90 מ"מ"כ, במעבדה ערכי אשלגן 5 mmol/L, יש לבדוק יחס רנין/אלדוסטרון.
ב. בן 55, סוכרת מסוג 2 ויתר לחץ דם, לאחרונה הוסף לטיפול Atacand (Candesartan) 8 מ"ג. לאחר חודש טיפול קריאטינין עלה ב-25%. יש לבצע דופלקס של עורקי הכליה.
ג. בן 35, לאחרונה עלייה במשקל, לחץ דם 135/85 מ"מ"כ. בדיקת סוכר בצום 110 מ"ג/ד"ל, HBA1C 5.9%, יש לבדוק Lipoprotein A.
ד. בת 50, לחץ דם 150/90 מ"מ"כ, לאחרונה עלה 170/90, מטופלת ב-Exforge (Amlodipine/Valsartan), סוכר בצום 100 מ"ג/ד"ל, רמת קראטינין 1 מ"ג/ד"ל. בהולטר לחץ דם – Nondipper. מומלץ לבצע בדיקות קורטיזול בצום ומבחן דיכוי דקסמטזון.

7. בן 70 סובל משיהוקים (Hiccups) בלתי פוסקים מזה כחודשיים. עבר בירור נרחב אשר שלל את האתיולוגיות השונות. מבקש טיפול להפסקת השיהוקים.

מה הטיפול שניתן להציע לו?

א. Dexamethazone (Dexacort) 4mgX1day.

ב. Amitriptyline (Elatrolet) 10 mgX1/day.

ג. Diazepam (Assival) 5 mgx1/day.

ד. Baclofen (Baclosal) 5 mgX3/day.

8. מה מהבאים נכון לגבי ירידה בחשק מיני באישה בת 61 הלוקה ב-hypoactive sexual desire disorder?

א. ניתן לטפל על ידי מתן סיסטמי/מקומי של אסטרוגן.

ב. טיפול בטסטוסטרון יכול לשפר חשק מיני, אך לא מאושר FDA.

ג. SSRIs במינון נמוך הוכחו כיעילים.

ד. אף טיפול תרופתי לא הוכח כיעיל, יש להציג בפני האישה טיפולים לא תרופתיים.

9. בת 50, אובחנה לאחרונה עם סרטן השד דרגה IIb. מעוניינת לחתום על הנחיות מקדימות וכשירה לכך.

לפי חוק זכויות החולה הנוטה למות מהו ההסבר המתאים?

א. במידה שבעקבות הכימותרפיה יחול סיבוך ותידרש להחייאה - ההנחיות אינן תקפות במקרה זה.

ב. ניתן להנחות להימנע מהנשמה מלאכותית רק כאשר תוחלת החיים היא פחות משבועיים.

ג. תוקף ההנחיות המקדימות הוא למשך 10 שנים או יותר – אם תאבד את כשירותה במהלכן.

ד. מאחר והמטופלת היא חולה הנוטה למות, בעת מילוי הטפסים עליה לקבל הסברים ממומחה לאונקולוגיה.

10. בת 14, האם מודאגת משום שהבת ממעטת באכילה ועוסקת בספורט בצורה אינטנסיבית. ירדה במשקל.

הבת מציינת שהיא פוחדת להעלות במשקל מחשש שחברותיה יצחקו עליה.

מה יכול להיות אחד הסיבוכים של המחלה ממנה המטופלת סובלת?

א. Leukocytosis.

ב. Osteoporosis.

ג. Hyperkalemia.

ד. Hyperthermia.

11. בן 60, ברקע - עישון של 40 שנות קופסא שהופסק לפי 4 שנים. אובחן COPD ולא הוחל טיפול. בשנה האחרונה אושפז עם החמרה. כעת בבדיקה ספירומטרית $FEV_1=72\%$ וציון CAT הוא 15. רמת אאוזינופילים בדם מתחת ל-100.

מהו הטיפול המתאים בשלב הזה?

א. LAMA בלבד.

ב. ICS+LABA.

ג. ICS +LABA+ LAMA.

ד. LABA+ LAMA.

12. בן 48, מזה מספר שנים רעד סימטרי בידיים, ללא תלונות נוירולוגיות או קוגניטיביות נוספות. מספר כי הרעד מחמיר בתנועה ולא מופיע במנוחה.

מה נכון לגבי רעד מסוג זה?

א. טיפול בתרופות כגון Levodopa עשוי לשפר את המצב.

ב. שתיית אלכוהול עלולה להחמיר את הרעד.

ג. שכיח סיפור משפחתי דומה סביב אותו טווח גילאים.

ד. שימוש בחסמי ביטא עשויים להחמיר את הרעד.

13. פותח מכשיר בעל יכולות איתור נגעים עוריים ממאירים.

במסגרת מחקר נבדקה הרגישות של המכשיר אל מול ביופסיה מהנגע בקרב 200 נבדקים.

המכשיר אבחן בצורה נכונה נגעים בקרב 60 מטופלים מתוך 80 עם ממאירות עורית, וכן אבחן נכונה נגעים בקרב 25% מהמטופלים עם נגעים שפירים.

מהו ה-NPV (Negative Predictive Value)?

א. 40%

ב. 60%

ג. 25%

ד. 75%

14. בן 70, ברקע - אי ספיקת כליות כרונית מתקדמת CKD 4, פרפור פרודוריים מטופל ב- Eliquis (Apixaban), ואירוע מוחי איסכמי לפני 3 שנים, מטופל באספירין. עבר אירוע כלילי חריף מסוג STEMI, בצנתור הושם תוכמן מפריש תרופה (Drug Eluting Stent, DES).

בתור תוספת טיפול מה תרופת הבחירה נוגדת הטסיות המתאימה ביותר עבור מטופל זה?

א. Plavix (Clopidogrel).

ב. Effient (Prasugrel).

ג. Brilinta (Ticagrelor).

ד. Eliquis (Apixaban).

15. איזו חבלה או סימן רנטגני יחשיד להתעללות?

א. בת שנתיים לא מזיזה את יד ימין, בצילום נצפה Pulled Elbow.

ב. בן חודש באי שקט וחום, בצילום - קלוס בעצם הבריח השמאלית.

ג. בת 3 שנים, שבר ספירלי בטיביה הדיסטלית הימנית.

ד. בן שנה, שבר בחלק האחורי של הצלע.

16. בת 58 מגיעה למרפאת האחות לצורך טיפול בפצע בשוק. ברקע - סוכרת והשמנה (BMI 31). ללא טיפול תרופתי קבוע. הביקור האחרון שלה במרפאה היה לפני 6 שנים, אז נמדד לחץ הדם 143/85 מ"מ כ"ס. האחות חבשה את הפצע ומדדה לחץ דם של 203/117 מ"מ כ"ס במספר מדידות. המטופלת מרגישה טוב, ללא כאבי ראש, ללא סחרחורות, ללא טשטוש ראייה, ללא חולשת צד, ללא קוצר נשימה, ללא כאבים בחזה. בדיקה גופנית תקינה למעט היעדר דפקים פריפריים בכפות הרגליים דו"צ.

מה יש לעשות כעת?

א. להתחיל טיפול תרופתי פומי ולהזמין למעקב בימים הקרובים.

ב. לפנות למיון באמבולנס עבור טיפול תוך ורידי להורדת לחץ הדם תוך מספר שעות.

ג. להוריד את לחץ הדם לערכי לחץ דם מתחת ל-160/100 בעזרת Captopril במרפאה.

ד. להנחות את המטופלת למדוד לחץ דם בבית במשך שבוע ולחזור לביקורת עם התוצאות.

17. מטופלת עם שינוי בצבע אצבעות בידיים ללבן ולאחר מכן כחול בחשיפה לקור המלווה בכאב. לאחר חימום האצבעות הן חוזרות לצבען המקורי.
מה מגורמי הרקע של המטופלת מכון כי מדובר במופע שניוני של התופעה?
א. מין נקבה.
ב. עישון.
ג. היפותירואדיזם.
ד. מיגרנות.
18. בת 68, מעשנת, ידוע על סוכרת ויתר לחץ דם. בבדיקת צפיפות עצם עדכנית נצפו ערכי T score בפרק הירך (2.2-) ובעמוד שדרה מתני (2.1-). מקבלת תוספי סידן וויטמין די.
מהם השיקולים להחלטה על התחלת טיפול למניעת שברים?
א. ב- FRAX הסיכון לשבר אוסטרופורוטי ב-10 השנים הבאות הוא מעל 3% בצוואר הירך ומעל 20% לשברים אוסטרופורוטיים.
ב. קיים סיכון מוגבר לשברים עקב עישון וסוכרת.
ג. בעברה שבר בשורש כף היד בעקבות תאונת דרכים.
ד. תוצאות הבדיקה הנוכחית מספקות להתחלת טיפול.
19. מטופלת בשבוע 3+10 ימים להריונה, מגיעה לבדיקה נסערת בשל תשובה פתולוגית של משטח מצוואר הרחם (PAP SMEAR) עם ממצא של CIN 2.
מה הברור והטיפול הנדרשים בעקבות הממצא הנ"ל במטופלת זו?
א. לבצע קולפוסקופיה וגרדת תעלת צוואר הרחם (ECC) בהקדם.
ב. לבצע קולפוסקופיה ואם האבחנה אכן CIN 2 מומלץ מעקב בלבד.
ג. להמליץ על הפסקת הריון בהקדם בשל הסיכון להתמרה סרטנית במהלך ההריון.
ד. אסור לבצע ביופסיה מצוואר הרחם בהריון בשל סיכון גבוה להפלה ודימומים.

20. בן 4 שנים סובל מחום עד 40 מעלות צלזיוס וצליעה מזה כשבוע ימים עם רגישות ממוקמת באיזור הטיביה הימנית, ללא כאב באיזורים אחרים.
מה נכון לגבי בירור בחשד לאוסטאומיאליטיס?
א. צילום רנטגן יראה ממצאים רק לאחר 4-8 שבועות.
ב. ספירת דם תקינה שוללת את האבחנה.
ג. ערכים תקינים של CRP מבטלים את הצורך בבצוע תרבית דם.
ד. הדמיית הבחירה במקרה זה היא בדיקת MRI של שוק ימין.
21. בן 60 מלין על קושי בתחילת הטלת השתן, זרם חלש והרגשת חוסר התרוקנות מלאה. לפי על קול (US) הודגמה הגדלת הערמונית.
מה הם עקרונות הטיפול ב-Duodart (Dutasteride-tamsulosin)?
א. מוריד סיכון להמטוריה חוזרת עקב הגדלת הערמונית.
ב. יעילות הטיפול יורדת עם עליית PSA.
ג. יעילות הטיפול יורדת אם נפח הערמונית היא יותר מ-50 סמ"ק.
ד. לא מוריד סיכון להתקדמות לניתוח Prostatectomy.
22. בן 58, ברקע - מחלת לב איסכמית, טרום סכרת, השמנת יתר ודיכאון. מטופל ב-Metformin, Aspirin, Sertraline, Ramipril, Bisoprolol.
מזה חודש וחצי מתלונן על כאב בטן אפיגסטרי לסירוגין, ללא הקאות, ללא ירידה במשקל. הכאב מוקל אחרי מזון, ביומיים האחרונים מדווח על צואה שחורה. בבדיקה רקטלית רושם למלנה (melena).
איזו תרופה בשילוב עם אספירין מעלה את הסיכון לאבחנה המשוערת?
א. Bisoprolol (Cardiloc).
ב. Metformin (Glucophage).
ג. Ramipril (Tritace).
ד. Sertraline (Serenada).

23. מחקר השווה בין 8,276 חולי סוכרת עם דמנציה לעומת 8,276 חולי סוכרת ללא דמנציה התואמים להם מבחינת גיל ומין. במחקר זה נבדקו התרופות אותן נטלו המטופלים לסוכרת, ונבדק הקשר בין נטילת תרופות שונות לסוכרת לבין התפתחות דמנציה.

מהו הממד המתאים לתיאור גודל האפקט בסוג המחקר המתואר?

א. Odds Ratio

ב. Relative Risk

ג. Confidence interval

ד. Kaplan-Meier analysis

24. בן 38, לא מעשן, ללא תסמינים נשימתיים.

לקראת כריתת ליפומה בגב עליון בוצעה בדיקת CT חזה, נצפו ברונקיאקטוזות דו צדדיות באונות העליונות, ללא עדות לנפחת (Emphysema).

מה יכלול הבירור לאטיולוגיה הסבירה ביותר?

א. תפקודי בלוטת המגן.

ב. ברונקוסקופיה.

ג. תבחין זיעה (Sweat test).

ד. רמת Alpha-1-Antitrypsin.

25. מי מהמקרים הבאים דורש המשך בירור?

א. בן 14, סינקופה במהלך משחק כדורסל.

ב. בן 16, חום 39 מ.צ., התעלף אחרי קימה מהמיטה והטלת שתן.

ג. בן 5 התעלף לאחר בדיקת דם, לפני כן נראה חיוור.

ד. בת 13, סינקופה לאחר עמידה ממושכת בשמש.

26. בת 55, במנופאוזה, BMI 32. מתלוננת על עייפות מזה 6 חודשים.
ברקע – יתר לחץ דם, מטופל ב-Norvasc (Amlodipine), Vector (Valsartan), Disothiazide.
בדיקה גופנית ומעבדתית תקינות למעט ל"ד 160/89 מ"מ"כ.
מה הבדיקה המתאימה ביותר כעת?
א. הגברת הטיפול בל"ד, המשך מעקב במרפאה.
ב. בדיקה במעבדת שינה.
ג. שאלון PHQ9.
ד. בדיקת נקודות רגישות.
27. בן 43, לוקה בסכיזופרניה, ללא טיפול תרופתי קבוע, ללא מעקב פסיכיאטרי בשל סירובו. מתגורר בבית עם אשתו ובתו התינוקת. פנית למטופל טלפונית למעקב. המטופל מתאר ששומע קולות שפוקדים אותו. שולל שמתכוון לפגוע בעצמו או באחר. הצעת לו להגיע לבדיקת פסיכיאטר והוא מסרב.
מתי יש לפנות לפסיכיאטר מחוזי להוציא הוראה לבדיקה כפויה דחופה?
א. המטופל מסתגר בחדר ולא אוכל עם משפחתו מחשש שהאוכל שמקבל מורעל.
ב. לבוש בצורה שלא תואמת את מזג האוויר, לא מתרחץ ולא מצחצח את שיניו.
ג. עוקר שתילים באי תנועה סמוך לביתו וטוען כי יש בהם משדרים המשדרים למוחו.
ד. מרסס את ביתו בכמויות גדולות של תרסיס לקטילת חרקים כי חושש ממתקפת עטלפים.
28. בת 30, סובלת ממיגרנות תכופות ושואלת על טיפול מונע. ניסתה טיפול CBT וביופידבק ללא הטבה.
מהם השיקולים בבחירת הטיפול המומלץ?
א. Atenolol (Normiten) מועדף במטופלת עם רקע של דיכאון.
ב. Amitriptyline (Elatrol) מועדף במטופלת עם רקע של פרכוסים.
ג. Topiramate (Topamax) מועדף במטופלת בעודף משקל.
ד. Valproic acid (Valproate) מועדף במטופלת שמתכננת היריון.

29. בן 80, ברקע - יתר לחץ דם, סוכרת ובריחת שתן. לאחרונה מתקשה בחשבון פשוט אך מצליח להתנהל באופן עצמאי בבית. נופל הרבה בתקופה האחרונה.

מה מומלץ כדי למנוע נפילות במטופל זה?

א. מתן ויטמין D במינון של 800-1000 יחידות ליום.

ב. להתחיל טיפול תרופתי ב-Toviaz (Fesoterodine) למניעת נוקטוריה.

ג. להתחיל טיפול בתרופות מקבוצת Z-drug למניעת קימה בלילה.

ד. להתחיל טיפול כגון Betistine (Betahistine) כדי למנוע סחרחורת.

30. בן 3 מגיע למרפאה עם אימו, האמא מספרת כי בזמן משחק עם הילד משכה את ידו הימנית, מיד לאחר מכן התלונן על כאב ומסרב להניע.

מהי הגישה המתאימה ביותר כעת?

א. לשלוח בהקדם לצילום במיון ילדים.

ב. לקבע את ידו הימנית עם סד.

ג. אין לבצע מניפולציה החזרה על ידי הורים או צוות לא מיומן.

ד. לבצע מניפולציה להחזרת הליגמנט למקומו.

31. בן 60, מעשן, אובחן כי לוקה ב-COPD. בשלושה חודשים אחרונים החמרה בשיעול ובקוצר נשימה, בבדיקות דם Hb 17 גר/ד"ל, Hct 52%, Eos 90.

מטופל ב-Oxis (Eformoterol) ו-Spiriva (Tiotropium bromide).

מהו הצעד הבא בטיפול?

א. Singulair (Montelukast).

ב. Azenil (Azithromycin).

ג. Ventolin (Salbutamol).

ד. Budicort (Budesonide).

32. בת 28, סובלת מזה מספר שנים משלשולים לסירוגין וכאב בטן. עברה הערכה אנדוסקופית בשאלה של Inflammatory Bowel Disease (IBD).

איזה מהממצאים הבאים יחזק אבחנה של Ulcerative Colitis?
א. היצרויות לאורך מערכת העיכול.

ב. ניתן לראות PSEUDOPOLYPS בקולונוסקופיה.

ג. אזורי דלקת בין אזורי רירית תקינה (SKIP LESIONS).

ד. בביופסיה ניתן לראות מעורבות טרנסמוראלית של המעי.

33. בת 28, בשבוע 7 להריונה הראשון, ברקע - אבחנת דכאון מאג'ורי לפני שנה, מטופלת ב-Lustral (Sertraline). מתייעצת לגבי המשך הטיפול התרופתי בהתחשב בהריונה.

מהי ההתייחסות לגבי טיפול תרופתי בדיכאון במהלך ההיריון?

א. הפסקת טיפול כרוכה בסכנה להישנות מצב דיכאוני במידה ומדובר באירועים חוזרים של דכאון או דיכאון קשה.

ב. הסכנה לעובר בהמשך טיפול בתכשירי SSRI גבוהה יותר מהשפעת דכאון מג'ורי על העובר.

ג. שימוש ב-SSRI בטרימסטר שלישי מעלה סיכון למצוקה נשימתית בילוד ולכן יש להפסיקו לקראת הלידה.

ד. טיפול בתכשירי SSRI במהלך הריון דורש הפחתת מינון כדי להקטין את הסכנות לעובר.

34. בן 60, ברקע - יתר לחץ דם ועודף שומנים בדם. נוטל Crestor ,Tritace (Ramipril) 5mg
(Rosuvastatin) 10 mg.

נשלח לאקו לב על רקע בירור של קוצר נשימה במאמץ.

לחץ דם נמדד במרפאה 125/80 מ"מ"כ, דופק 70 לדקה.

הממצאים באקו לב:

.Visually Estimated Ejection Fraction (LVEF) - 55%

.Borderline LV function

.Aortic valve area - severe stenosis

.Mild tricuspid regurgitation

.Mild pulmonary hypertension

.Dilated LA

מה הטיפול המומלץ?

א. תוספת חסמי תעלות סידן.

ב. תוספת דיזותיאזיד.

ג. החלפת מסתם אאורטלי.

ד. תוספת חסמי בטא.

35. בן שנה ו-3 חודשים, מחוסן כפי גילו, לפני ניתוח שתל שבלול (cochlear implant).

מה מומלץ ביחס לחיסון כנגד Pneumococcus טרום הניתוח?

א. לשקול על פי מצבו הבריאות מתן חיסון נוסף.

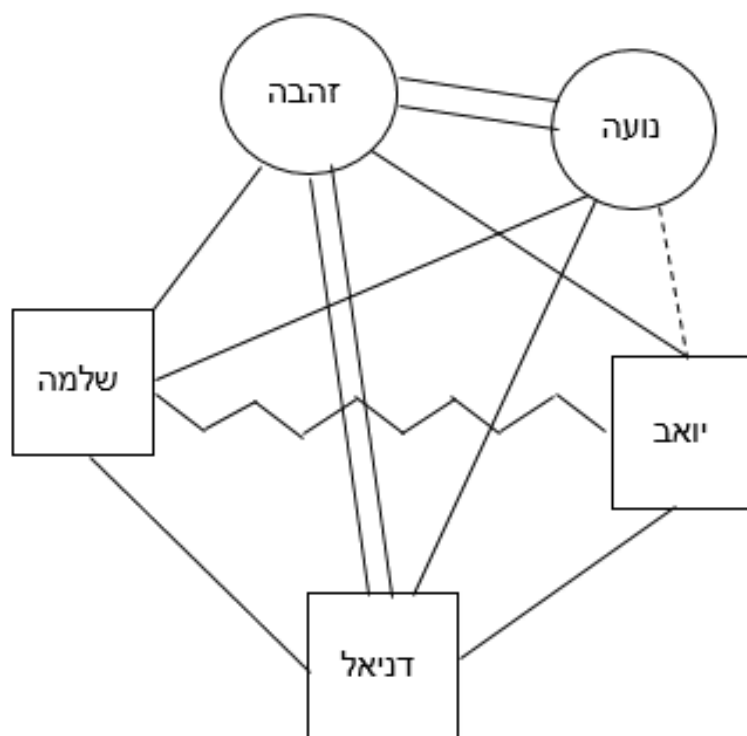
ב. לחסנו עם מנה נוספת של Prevenar 13 (PCV13).

ג. לתת שתי מנות של Prevenar 13 (PCV13) בהפרש של שבועיים.

ד. לחסנו עם מנה של Pneumovax (PPV23).

בחינת שלב א' רפואת המשפחה 30.09.24

36. שלמה בן 59, חולה פרקינסון מאוזן תרופתית, נשוי לזהבה בת 58, לוקה בסוכרת. לזוג 3 ילדים: נועה בת 32, נשואה +1, יואב בן 28, יוצא למפגשים אקראיים עם בנות זוג, ודניאל בן 25, רווק. יואב ודניאל מתגוררים בבית הוריהם.



איזו מסקנה ניתן להסיק לגבי המשפחה המתוארת?

- א. לפי מודל McGoldrick & Carter יואב נמצא בשלב "הצעיר הבודד".
- ב. מתוך הפסיכופיגורה בלבד (נספח X) ניתן להסיק את מבנה המשפחה והשלב במעגל החיים.
- ג. הקשר בין יואב ושלמה רופף.
- ד. הקשר בין נועה ויואב מעיד על מחלוקות מרובות.

37. בן 57, ברקע – השמנה, יתר לחץ דם. מתלונן על כאבים ונפיחות בברך ימין מאתמול. ללא חום סיסטמי, ללא חבלה. מעברו: לפני 6 שנים אירוע של כאבים ונפיחות בבוהן ימין שחלף בטיפול ב-Etopan (Etodolac). בבדיקה: אודם רב, חום מקומי, נפיחות, הגבלה בטווחי תנועה. מהי ההמלצה הטיפולית המתאימה ביותר?
- א. לשלב טיפול בתכשיר NSAIDs עם Ceforal (Cephalexin).
ב. להתחיל מיד טיפול נוגד דלקת בשילוב עם Feburic (Febuxostat).
ג. להתחיל כעת תכשיר NSAIDs בשילוב עם טיפול Alloril (Allopurinol).
ד. לטפל בתרופות מקבוצת NSAIDs, Colchicine או Prednisone.
38. בת 75, בריאה ברקע. מגיעה לבדיקה עקב כאב ואודם ברגלה שהחל לפני יומיים. ללא תלונות נוספות. בבדיקתה נמוש וריד טרומבוטי ורגיש עם אודם סביבו. מהו המשך הבירור?
- א. יש לבצע סונר דופלקס.
ב. יש להפנות לספירת דם דחופה.
ג. האבחנה קלינית, אין צורך בהמשך בירור.
ד. יש להפנות לבדיקה של אורתופד.
39. באילו מקרים יש לטפל בבקטריאוריה אי תסמינית (Asymptomatic bacteriuria)?
- א. בת 39, ברקע - סכרת הריון, שבועיים אחרי לידה.
ב. בן 79, לוקה סכרת, ישנם פגיעה באיברי מטרה ומיקרואלבומין בשתן.
ג. בן 60, ידוע על הגדלת הערמונית, מועמד לניתוח Prostatectomy.
ד. בת 45, ברקע - סרטן שד, מטופלת בטיפול קרינתי.

40. בת 30, BMI 32, פונה עקב התקרחות המדוגמת בתמונה והופעת תישעורת בפנים.
ללא ממצאים עוריים נוספים.



איזו בדיקה תכון לגורם הסביר ביותר?

א. Ferritin

ב. TSH

ג. Estradiol

ד. LH/FSH

41. מי זכאי לגמלה על פי חוק סיעוד?

א. בן 64, זקוק לעזרה באכילה רחצה הלבשה וטיפול בהפרשות.

ב. בן 70 עצמאי בתפקוד basic ADL, זקוק להשגחה ביתית עקב ירידה קוגניטיבית.

ג. בת 80 מתגוררת במחלקה סיעודית, זקוקה לעזרה ב-ADL ומוזנת על ידי זונדה.

ד. בת 67 שעברה להתגורר עם בתה בצרפת בשל ירידה תפקודית משמעותית.

42. בן 50, מעשן, מתלונן כי מזה כחודש סובל מנפיחות בצוואר ובפנים, בלט ואודם בשתי העיניים. ללא צרידות וללא קוצר נשימה. ללא תלונות נוספות. בבדיקה גופנית – ל.ד. 110/70 מ"מ"כ, דופק 90 לדקה. בצקת בפנים, הרחבה של ורידי הצוואר, בצקת וגודש בשתי הלחמיות ובלט עייני דו צדדי. בדיקה נירולוגית תקינה.

מהי הבדיקה המיידית שתאשר את החשד הקליני הסביר ביותר?

א. אקו לב.

ב. דופלר של עורקי התרדמה (Carotis arteries).

ג. בדיקת CRP, ספירת דם, TSH.

ד. CT חזה עם חומר ניגודי.

43. בת 30, נשואה ואם לילד, בריאה, גילתה שהיא בהריון בלתי מתוכנן. מעוניינת להפסיק את ההריון.

מה אומר החוק בנושא של הפסקת הריון?

א. ניתן לאשר הפסקת הריון מחמת גילה של המטופלת.

ב. הוועדה חייבת לקבל הסכמת הבעל להפסקת הריון.

ג. הוועדה רשאית לאשר את הפסקת ההריון אם יוכח שההריון עלול לפגוע בבריאותה הנפשית של המטופלת.

ד. ניתן להפנות לוועדה להפסקת הריון רק לאחר הוכחת קיום מומים אצל עובר.

44. בן 70 מלין על כאבים בכפות הרגל באזור בסיס MTP1 מזה כשנה. שולל חבלה. ללא אירועי חום או אודם

מקומיים. בבדיקתו: בליטה נוקשה בחלק הדורזלי של MTP1 וכן כאבים, קרפיטציות והגבלה ניכרת ב-

dorsiflexion של הבהונות. בצילום נצפה Spur מעל המפרק.

מהו הטיפול המומלץ?

א. שימוש ב-Morton's extension.

ב. Xanthine oxidase inhibitor (Oxypurinol).

ג. ניתוח לקיבוע המפרק.

ד. שימוש ב-NSAIDs בזמן התלקחות.

45. בת 4 וחצי שנים, נולדה במועד במשקל תקין, התפתחות תקינה, מחוסנת בהתאם לגילה, בריאה.

מה מהבאים מומלץ לפי המלצות כוח המשימה הישראלי בנושא קידום בריאות ורפואה מונעת?

א. צפייה במסכים עד 3 שעות ביום.

ב. פעילות גופנית בזמן מצטבר של 60 דקות ביום.

ג. חיסון שפעת שנתי, יש לחסן באמצעות חיסון מומת בלבד.

ד. בעת חשיפה לשמש יש להשתמש במקדמי הגנה SPF 30 ומעלה.

46. למי מהמטופלים הבאים תקבע אבחנה של יתר לחץ דם?
- א. בן 46, במדידה אקראית בודדת בבית נמדד ל"ד 138/88 ממ"מ כ.
ב. בת 37, בהולטר לחץ דם מדידות בשינה 120/85 ממ"מ כ.
ג. בן 82, במדידות עוקבות במרפאה ל"ד 135/88 ממ"מ כ.
ד. בת 27, הריון שבוע 33, במדידות עוקבות במרפאה ל"ד 135/87 ממ"מ כ.
47. מהם השיקולים בבחירת טיפול אנטיהיסטמיני ממשך למטופל עם נזלת אלרגית?
- א. Fexofenadine (Telfast) לא מומלץ עקב חשד להארכת מקטע QT.
ב. Loratadine (Lorastine) יותר יעיל מאנטי-היסטמינים מהדור הראשון.
ג. Chlorpheniramine (Ahiston) עלול לגרום לעצירות כרונית.
ד. Cetirizine (Zylergy) הכי פחות מרדים מבין אנטי-היסטמינים מהדור השני.
48. בן 30, בריא ברקע. מתלונן על כאבי עצמות, כאבי בטן, ירידה במצב רוח. לפני מספר ימים היה התקף של כאבי מותניים עזים וקושי בהשתנה. בבדיקות דם נמצאה רמת סידן של 11mg/dl, ו-PTH של 300 pg/ml. תפקודי כליות תקינים.
- מה בסיפור המשפחתי תומך בחשד ל-Multiple Endocrine Neoplasia (MEN)?
- א. סוכרת ו-Gout.
ב. סרטן המעי הגס.
ג. מחלה פוליציסטית של הכליות.
ד. אדנומות בלבלב או ביותרת המוח.
49. במי מהמטופלים הבאים הפרדות רשתית היא האבחנה הסבירה ביותר?
- א. בת 75, ברקע קוצר ראייה משמעותי, מהבוקר רואה דברים צפים ואורות מנצנצים בעין שמאל.
ב. בן 48, ברקע סכרת לא מאוזנת, יל"ד, מחלת לב איסכמית. מספר על ירידה חדה בראייה בעין ימין שהתפתחה תוך דקות.
ג. בת 22, סובלת מכאבי ראש כרוניים, הבוקר אירוע של 20 דקות בו ראתה אורות מנצנצים, נקודות עיוורות (blind spots) וקווים בצורת זיגזג.
ד. בן 68, ברקע עישון והיפרליפידמיה, מספר על ירידה הדרגתית בראייה, בחודשים האחרונים יש עיוות של קווים ישרים בראייה (metamorphopsia).

50. בן 30 מגיע לביקור על רקע כאבי בטן כרוניים מהם הוא סובל. לאחרונה לחבר מהעבודה אובחן גידול ממאיר במערכת העיכול.

- אלו מהשאלות הבאות מייצגות doctor-centered interviewing (בניגוד ל-patient centered interviewing)?
- א. ממה אתה הכי מוטרד?
 - ב. מה מחמיר ומה מקל על הכאב?
 - ג. כיצד הכאב משפיע על מהלך היום יום שלך?
 - ד. כיצד לדעתך אוכל לעזור לך?

51. בן 68, מתלונן על רעד בגפיים שהולך ומחמיר בשלוש השנים האחרונות.

מה מהבאים תומך באבחנה של פרקינסון?

- א. הרעד סימטרי ומתגבר בזמן כתיבה.
- ב. הרעד קיים ברגליים בלבד ללא מעורבות של הידיים.
- ג. בבדיקתו הגופנית רושם לניסטגמוס ומבחן אצבע-אף לא תקין.
- ד. ניסיון טיפול ב-Levodopa (L-Dopa) גרם להופעת דיסקינזיות.

52. בן 57, ברקע - עצירות לסירוגין עם טיפול במשלשלים לפי הצורך. מזה 3 ימים מתלונן על כאב בבטן שמאלית תחתונה, ללא בחילות או הקאות. במרפאה נמדד חום 38.2 מ.צ. בבדיקה: רגישות במישוש הבטן ברביע שמאלי תחתון, ללא סימני גירוי צפקי. בקולונוסקופיה שבוצעה לפני 3 שנים נצפו סעיפים במעי היורד.

מה הצעד המתאים ביותר להמשך ניהול המקרה?

- א. דיאטת נוזלים צלולים ואנטיביוטיקה רחבת-טווח.
- ב. הפניה ל-CT בטן דחוף.
- ג. ביצוע קולונוסקופיה חוזרת תוך שבוע.
- ד. דיאטה דלת סיבים ואנטיפירטיקה.

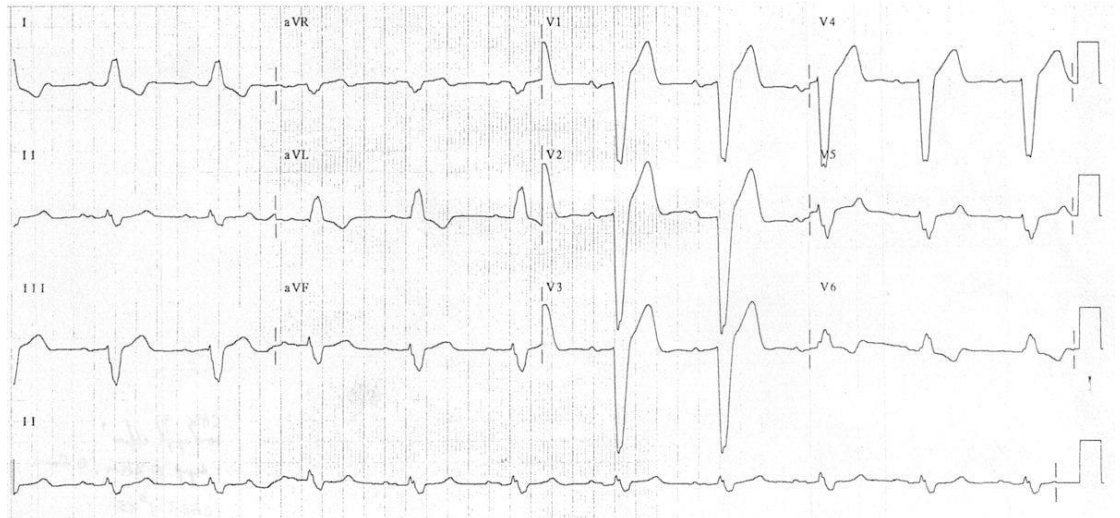
53. בן 56, ברקע - מספר אירועים של אבנים בכליות.

לפי תוצאות מעבדה האבן מורכבת ממלחי סידן.

מה נכון לגבי התערבות מניעתית מפני חזרת האבן?

- א. שמירת משקל סגולי של השתן מעל 1.010.
- ב. הפחתת שתיית משקאות מוגזים.
- ג. הגברת צריכת נתרן.
- ד. תזונה עתירת חלבון מין החי.

54. בן 56, בריא בד"כ, מתלונן על מיחושים לא ספציפיים בחזה. הכאב בעל אופי צורב/שורף, אינו מוחמר לאחר מאמץ גופני, אינו מוחמר במישוש שרירי בית החזה, לא מקרין. אין בידו תרשים א.ק.ג. קודם להשוואה. מצורף תרשים א.ק.ג. שבוצע בביקור הנכחי:



מה השלב הבא בניהול המקרה אצל מטופל זה?

- א. הפניה למבחן מאמץ.
- ב. טיפול ב-Omeprazole 20 מ"ג פעמיים ביום למשך חודש.
- ג. הפניה לבדיקת טרופונין דחופה.
- ד. הפניה ל-CT קרדיאלי.

55. בן 3 שנים, מאובחן עם autism spectrum disorder ופוקד מעון שיקומי. במצבו הבסיסי משחק בד"כ בדובי קבוע, ובעזרת תיווך מצליח להשתתף בשיחה לא מילולית באופן חלקי. עדיין לא נגמל מחיתול. אמו מספרת שבשבועיים האחרונים חלה נסיגה במצבו: הוא לא משתף פעולה במשחק, לא אומר את המילים שכבר למד ונראה לעתים לא מרוכז. אין חום, עצירות, נזלת, שיעול, הקאה או שלשול. אוכל ושותה כרגיל.

מהו הצעד הבא?

- א. תרבות שתן.
- ב. בדיקת אלקטרוליטים בסרום.
- ג. תחילת טיפול ב-Risperidone.
- ד. בדיקת EEG.

56. בת 88, סובלת מסוכרת ארוכת שנים. שלוש שנים ללא טיפול תרופתי. ברקע דמנציה, מתגוררת עם מטפלת 24/7. המטפלת דיווחה שהמטופלת שותה הרבה (10 כוסות ביום), ריבוי שתן, ובריחות שתן שלא היו עד כה. ירדה במשקל 6 ק"ג בחודש האחרון. במעבדה: רמת HbA1c % 11.8. מה הטיפול המומלץ למטופלת זו?
- א. התחלת טיפול ב-Januvia (Sitagliptin) יחד עם Forxiga (Dapagliflozin).
ב. אינסולין בזאלי וטיטרציה עד לשיפור בתסמיני ההיפרגליקמיה.
ג. מדידת ערכי סוכר 3 פעמים ביום ומתן אינסולין קצר טווח לפי רמות סוכר.
ד. בגילה ולאור הרקע הרפואי אין צורך להקפיד על איזון סוכרת.
57. בת 16 המאובחנת עם אנורקסיה נרוזה מזה כשנה וחצי, ממשיכה בירידה במשקל. הוחל טיפול מבוסס-משפחה. מה מאפיין טיפול זה?
- א. כחלק מהטיפול מועברת האחריות על ניהול האכילה למטופל.ת.
ב. הטיפול מתאים לאחר עליה של 25% מהמשקל ההתחלתי, או הופעה מחודשת של הווסת בנערות.
ג. לא הוכח כיעיל במחקרי RCT אך מחקרים תצפיתיים הראו יתרון על פני טיפול תרופתי בלבד.
ד. סיכויי הצלחת הטיפול גדולים יותר כשמתנהל במסגרת אשפוז ארוך טווח במוסד המטפל בהפרעות אכילה.

58. בן 52 פונה בשל כאבים אנאליים המופיעים בזמן יציאה ומלווים בכאב עז ביציאה, מזה כשבוע. ללא חום סיסטמי, ללא ירידה במשקל, ללא דם.
בבדיקה גופנית ממצא הבא:



מה מהבאים הוא הטיפול המתאים ביותר?

- א. משחה סטרואידלית עם לידוקאין כגון Cr.Procto-Glyvenol
- ב. מתן Laxatives.
- ג. מתן Tramadol לכאב.
- ד. זריקת Botox לאיזור הספינקטר האנלי.

59. בת 38, בריאה בדר"כ, אינה נוטלת תרופות קבועות, ללא סיפור משפחתי של סרטן שד. בחודשים האחרונים סובלת מכאב בשדיים. הכאב הינו דו"צ, לא ממוקד, ללא קשר למחזור החודשי. שוללת חבלה.
בבדיקה גופנית – שדיים ללא אודם או חום מקומיים, ללא הפרשה מהפטמה, לא נמוש גוש.

מהי הגישה לאבחון וטיפול המתאימה ביותר?

- א. בצוע ממוגרפיה, המלצה על דיאטה דלת שומן ועתירת סיבים.
- ב. אין צורך בהדמיה, טיפול ב-NSAIDs מקומיים והתאמת חזייה.
- ג. בצוע MRI שדיים, התאמת גלולות משולבות.
- ד. הפניה לסונר שדיים, המלצה להפחתת קפאין בשתייה.

60. בן 5, בריא בדר"כ, נולד במועד (שבוע 39) ומחוסן לגילו. מזה שלושה ימים נזלת, כאב גרון קל ביום הראשון למחלתו שחלף, שיעול יבש. ללא חום או תסמינים נוספים. בבדיקה גופנית מדדים חיוניים שמורים, בדיקת גרון וריאות ללא ממצא. נימושו קשריות לימפה צוואריות קדמיות דו"צ.

מהו הטיפול המומלץ ביותר למצבו?

א. Azenil (Azithromycin).

ב. Tamiflu (Oseltamivir).

ג. Phenylephrine נאזאלי.

ד. Saline nasal drops (Tipotaf).

61. בן 40, מאבטח, BMI 31. סובל מכאב חד בעקב בקימה בבוקר מזה שבועיים אשר משתפר במהלך היום. יש החמרה של הכאבים לקראת הערב בסיום הפעילות. ללא סיפור של חבלה.

מה נכון לגבי הטיפול לאבחנה הסבירה ביותר?

א. מדרסים יכולים להקל על הכאב בתקופה הראשונית.

ב. זריקות סטרואידליות יביאו להקלה לטווח הרחוק.

ג. גלי רדיו יכולים להתאים לטיפול עם הופעת התסמינים לראשונה.

ד. 40% יגיעו לטיפול כירורגי כעבור שנה מתחילת התסמינים.

62. ע"פ נייר העמדה של הר"י "הכנה לבדיקות פולשניות בחולים הנוטלים תרופות אנטי טרומבוטיות" (אפריל

2018) מי מבין המטופלים הבאים קיבל הנחיות התואמות את נייר העמדה מרופא המשפחה?

א. בת 60, סובלת מפרפור פרוזדורים, מטופלת ב-Xarelto (Rivaroxaban), מועמדת לניתוח קטרט בעין ימין, הונחתה להפסיק את הטיפול ב-Rivaroxaban 48 שעות לפני הפעולה.

ב. בן 75 מטופל ב-Coumadin (Warfarin) בשל מסתם מכאני שהושם לאחר MITRAL VALVE

REPLACEMENT, לפני שנה, מיועד לעבור עקירת שתי שיניים, הונחה ע"י רופא המשפחה להמשיך בטיפול ב-

Warfarin עם שמירת ה-INR סביב 3.

ג. בן 62, עבר לפני שבעה חודשים צנתור עם הכנסת תומכן Drug diluted stent (DES), מאז מטופל ב-Aspirin

ו-Plavix (Clopidogrel), מיועד לציסטוסקופיה. הונחה להפסיק את הטיפול באספירין ובפלביקס 3 ימים לפני הפעולה.

ד. בן 85 נוטל אספירין בשל אוטם שריר הלב שחוזה לפני עשר שנים. הונחה להמשיך אספירין לפני ניתוח

(TURP)TRANSURETHRAL PROSTATECTOMY.

63. במרפאה נמצאה שכיחות גבוהה יותר של סרטן השד בהשוואה לממוצע הארצי. שיעור בצוע בדיקות ממוגרפיה זהה לממוצע הארצי.

כיצד ניתן להסביר את התוצאות?

א. Selection bias

ב. Follow-up bias

ג. Verification bias

ד. Lead-time bias

64. קשיש בן 80, מורה בגמלאות, גר עם בנו. הבן מתלונן שלאחרונה אבא שוכח, ומבקש הפנייה לקביעת אפטרופוס לרכוש על אבא.

בדיקה MMSE שבוצעה לקשיש: 24/30.

מהי הפעולה הנכונה ביותר שעל הרופא לנקוט?

א. לזמן את הקשיש יחד עם בנו לבדיקה.

ב. לתת לבנו סיכום מידע רפואי בלבד.

ג. להיענות לבקשת בנו ולפנות לבית המשפט.

ד. להפנות לבדיקה במכון לבטיחות בדרכים.

65. יילוד בן 7 ימים הובא למרפאה עם דלקת לחמית Muco-Purulent. נולד בלידה נרתיקית עם פקיעת קרומים מוקדמת.

איזה מהבאים הוא הצעד הנכון הבא?

א. התחלה מיידית של טיפול פומי ב-Erythromycin.

ב. עיסוי מקומי של צינורות הדמעות.

ג. איסוף דגימות לתרבית מהלחמית מהאף והלוע.

ד. ניקוי עיניים וטיפול במשחת 5% Synthomycine (Chloramphenicol).

66. בת 40, מתלוננת על נשירת שיער. בבדיקה: התקרחות באזור ממוקד בקרקפת עם צמיחת שיער חלקית (partial regrowth).



מהו הבירור הנדרש?

- א. בדיקת TSH, ANA, ספירת דם.
- ב. בדיקת FSH, LH, estradiol, testosterone.
- ג. בדיקת רמות B12, פריטין, חומצה פולית.
- ד. ביופסיה מהאזור הפגוע.

67. בן 78, אלמן, עדיין עובד. מבקש סיכום מידע רפואי. לא ידוע על מחלות רקע. ללא תלונות כלשהן.

מהן בדיקות הסקירה שיש לבצע במקרה זה?

- א. בדיקת צואה לדם סמוי.
- ב. הערכה תפקודית.
- ג. בדיקת שמיעה.
- ד. סונר לאיתור מפרצת בטנית.

68. בן 35 סובל מירידה לא רצונית במשקל, טכיקרדיה, רגישות לחום ושלשול. בבדיקות הדם TSH 0.01 עם $T4=15 \mu\text{g}/\text{dl}$ (נורמה בין 5 ל-12).

באיזה מקרים תהיה קליטה מוגברת במיפוי של בלוטת התריס?

א. Type 1 Amiodarone-Induced Thyroiditis.

ב. Subacute thyroiditis.

ג. Metastatic thyroid malignancy.

ד. Struma ovarii.

69. בן 58, ברקע - יתר לחץ דם. מטופל ב-Norvasc (Amlodipine) 5 מ"ג. במסגרת מעקב מרפאתי נמדד לחץ דם 135/85 מ"מ. בבדיקות מעבדה שביצע לאחרונה eGFR 40. בבדיקת שתן יחס מיקרואלבומין/קראטנין 85 mg/g.

מהי ההמלצה הנכונה ביותר לגבי המשך הטיפול?

א. הוספת משתן מסוג Hydrochlorothiazide.

ב. עליה במינון Amlodipine ל-10 מ"ג פעם ביום.

ג. הפסקת Amlodipine והחלפתו בתרופה מסוג ACEI.

ד. הוספת תרופה מסוג ACEI.

70. בת 30, בהריון ראשון, שבוע 25, מגיעה למרפאתך בגין כאב גרון. במהלך בדיקתך אתה מבחין.נה בשטף דם כ-4 ס"מ באזור האמה הימנית. לשאלתך "האם המטופלת מרגישה מוגנת בביתה" היא מספרת תוך כדי כפי שבן זוגה לעיתים רחוקות נהג לצעוק עליה ולהשתמש במילות גנאי אך השבוע בפעם הראשונה זרק עליה ספר שפגע באמה. בבדיקתה הגופנית תקינה וללא ממצאים המחשידים לשבר.

מה על הרופא לעשות בשלב הבא?

א. להפנות למיין לצורך עירוב עו"ס ובדיקת אורטופד.

ב. בהעדר סיכון מידי לחייה לידע אותה למי ניתן לפנות לעזרה ולתעד.

ג. חובה לדווח למשטרה בכל מקרה לאור פגיעה באישה הרה.

ד. להזמין את בן זוגה לשיחה משותפת יחד עם עו"ס בהקדם לבירור.

71. מהי ההתייחסות לגבי תופעות הלוואי הבאות של גלולות למניעת הריון?
א. בחילות בשעות הבוקר שמקשות על תפקוד יומיומי - ניתן לעבור לתכשיר עם מינון אסטרון נמוך יותר או להחליף לגלולת פרוגסטרון בלבד.
ב. דימומים בתחילת המחזור שנמשכים מעל שלושת חודשי שימוש בגלולה - יש להחליף לתכשיר עם מינון אסטרון נמוך יותר.
ג. דימומים במחצית השנייה של המחזור שנמשכים מעל שלושה חודשים - יש להחליף לתכשיר עם מינון פרוגסטרון נמוך יותר.
ד. המרכיב האסטרוני בעל השפעה מגנה לבבית ולכן לנשים בסיכון מוגבר יחסית עדיפות גלולות עם מינון אסטרוני גבוה יותר.
72. שוחחת עם מטופל בן 65, המעשן 2 קופסאות ליום מגיל 15. שאלת אותו לגבי סיבות בעד ונגד הפסקת עישון, אמדת את מוכנות המטופל להפסקת עישון והצעת גישה לשינוי. לאחר מכן שיקפת למטופל את דבריו, הדגשת את הצלחותיו בעבר, והבעת תמיכה ואמפטיה.
מה נכון בנוגע לשיטת הביצוע שבה השתמש הרופא בריאיון עם מטופל זה?
א. השיטה משתמשת בדוגמא אישית של המטפל על מנת להשפיע ולגייס את המטופל לשינוי התנהגויות סיכון.
ב. השיטה מעריכה התנהגויות סיכון, משלבת הצעת ייעוץ והסכמה של המטופל עם התכנית, מסייעת להסיר מכשולים, ומתאימה את המעקב הנדרש.
ג. השיטה מסייעת לזהות את מידת המוכנות של המטופל להשתנות ומעודדת אותו להתקדם לכיוון שינוי התנהגותי המותאמת למידת המוכנות שלו.
ד. השיטה נועדה לסייע למטופל המתלבט אם לשנות את התנהגותו בהתבסס על יצירת הנעה לשינוי במטופל עצמו.
73. בת 39, אחות במקצועה, פנתה עקב היפוגליקמיה, סוכר בדם נמדד 50. בדיקת C-peptide נמוך. מבדיקה בתיק פניות מרובות למרפאות שונות מהו החשד האבחנתי הסביר ביותר?
א. Factitious Disorder משימוש באינסולין.
ב. Malingering.
ג. Insulinoma.
ד. היפוגליקמיה משנית ל-Sulfonylurea.

74. בת 28, ברקע בריאה, ללא טיפול תרופתי קבוע, ללא בן זוג קבוע. מתלוננת על חום עד 38.7 מזה 3 ימים. בשבועיים שקדמו לעליית החום סבלה מכאבים ממושטים לא ספציפיים במפרקים, נפיחות ואודם בקרסול ימין. הכאבים חלפו בהדרגה וכעת מאפשרים דריכה על הרגל אולם המטופלת שמה לב לתפרחת חדשה בגפיים תחתונות וכפות הידיים. שוללת חבלה.

בדיקתה – אודם ורגישות קלה בקרסול ימין. תפרחת: נגעים בודדים על פני השוקיים וכפות ידיים - נגעים פפולרים כואבים עם נמק מרכזי.



מהו הטיפול המתאים ביותר למצבה?

- א. להתחיל טיפול ב- Colchicine 0.5 מ"ג 3X ביום פומי.
- ב. לבצע ניקור מפרק הקרסול + טיפול ב- IV Rocephin (Ceftriaxone).
- ג. התייעצות אורתופדית בשאלה של MRI, ארתרוסקופיה או ניתוח.
- ד. להמליץ על מנוחה, הרמת הרגל, קירור מקומי ו-NSAIDs.

75. בת 15 בריאה ברקע, מתלוננת על כאבי בטן, הקאות, שלשולים וגזים לאחר שתיית חלב ואכילת גבינה ב-3 החודשים האחרונים. לא ירדה במשקל. מספרת שהתסמינים שלה חולפים כשהיא נמנעת ממוצרי חלב.

בדיקתה גופנית תקינה.

מהו השלב הבא בבירור?

א. תבחין נשיפת מימן ללקטוז.

ב. ספירת דם ובדיקת רמות Ferritin.

ג. התמונה הקלינית מספיקה לאבחנה.

ד. יש צורך בביופסיה של המעי הדק.

76. בן 70, מעשן, מתלונן על ירידה הדרגתית בראייה.

בבדיקתו - משקעים צהובים על הרשתית ואטרופיה של הרשתית.

פרט להפסקת עישון מהו הטיפול המומלץ לבעיה המתוארת?

א. נטילת תוסף ויטמינים נוגדי חמצון.

ב. נטילת תוסף בטא-קרופן.

ג. זריקות Avastin תוך עיני.

ד. טיפול בלייזר.

77. בת 7, בריאה, לא מחוסנת, שיחקה עם חבר אשר לאחר יומיים התגלה כחולה באבעבועות רוח.

אמה שואלת לגבי סיכויי ההדבקה ואופן הטיפול.

מהי ההמלצה המתאימה ביותר?

א. הסיכון להדבקה יומיים לפני הופעת המחלה אצל החבר מאד נמוך.

ב. לתת טיפול ב-Acyclovir 20 מ"ג/ק"ג 4X ליום למשך 5 ימים.

ג. במקרה של הדבקה יש להתחיל טיפול ב-Acyclovir.

ד. מומלץ לחסן את הבת תוך 5 ימים מהחשיפה.

78. בת 75, אלמנה ללא ילדים, ברקע - COPD קשה עם מחולל חמצן ביתי, אי ספיקת לב ימנית, השמנת יתר קיצונית ועישון כבד. בשנתיים האחרונות התקפים חוזרים של כאב בטן ימנית עליונה, מלווים בבחילות, במיוחד לאחר ארוחות.
- על קול (US) בטן הדגים אבנים ספורות בכיס המרה, גודלן עד 0.5 ס"מ. דרכי המרה ללא סימני חסימה. מהו הצעד המתאים ביותר להמשך ניהול המקרה?
- א. ניתוח אלקטיבי להסרת כיס מרה בגישה לפרוסקופית.
- ב. גסטרוסקופיה.
- ג. ניסיון טיפול ב-Ursolit [Ursodeoxycholic Acid] ומעקב סונוגרפי תקופתי.
- ד. המלצה על תזונה עשירה בפירות וירקות ושיכוך כאב לפי הצורך בהתקפים עתידיים.

79. בן 60, פנה עקב ממצאים בכף יד ימנית שהופיעו מזה מספר חודשים.
בבדיקה הממצא הבא (מצורפת תמונה):



מה מאפיין ממצא זה?

- א. מדובר בממצא זמני שחולף מעצמו.
- ב. המחלה ממקור גנטי, בגן אוטוזמלי דומיננטי.
- ג. מדובר בעיבוי של הגיד הפלקסורי.
- ד. המצב אינו כולל מעורבות של העור והרקמות הסמוכות.

80. בת 50, מתלוננת על גרד עיקש ב-vulva, בבדיקה אובחן Lichen Sclerosus. מהו הטפול המתאים ביותר לתלונתה?

- א. cream Lanacort 1% (Hydrocortisone).
- ב. Vag.cream Ovestin (Estriol).
- ג. Cr. Polycutan (Dexamethasone+Neomycin+Clotrimazole).
- ד. Oint.Betacorten (Betamethazone).

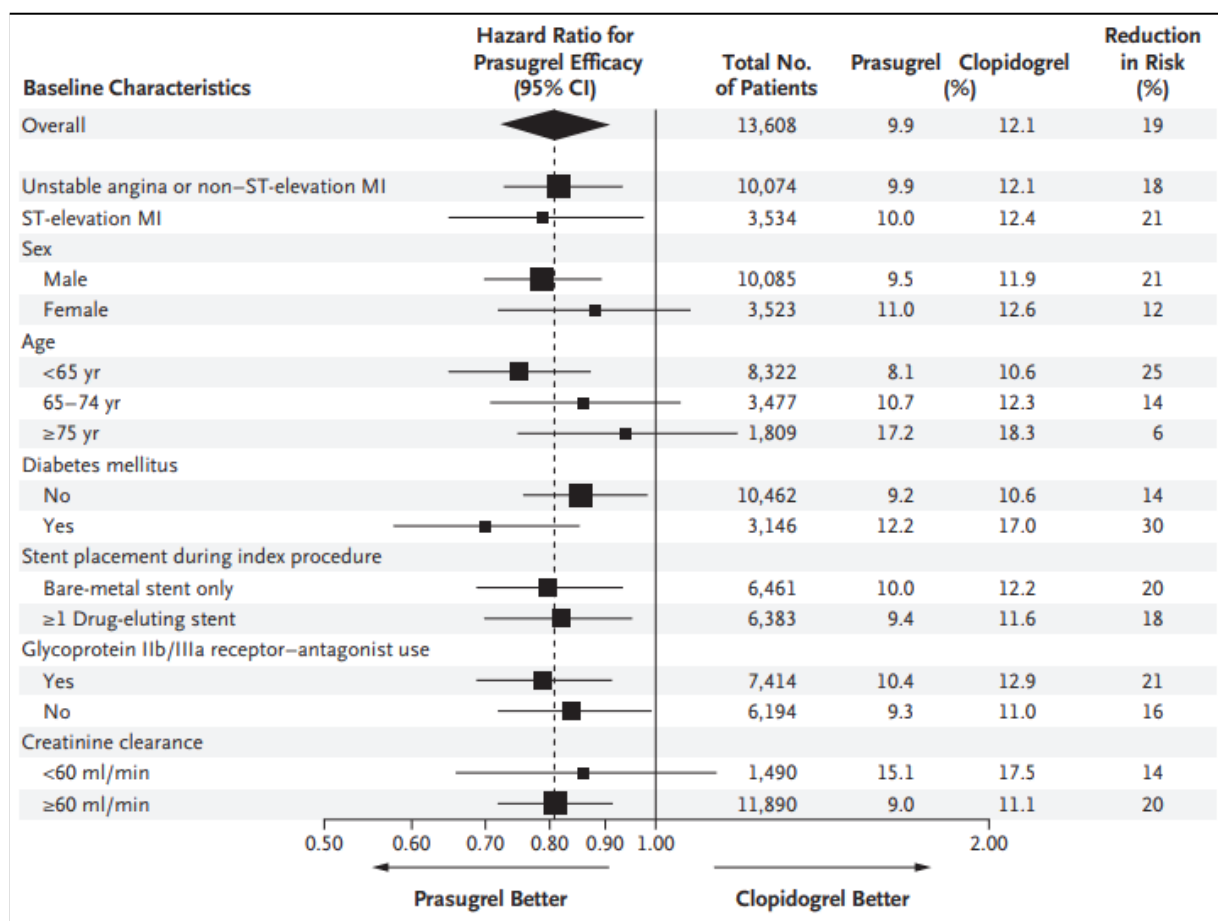
81. בת 57 בריאה בדרך כלל, מאובחנת עם Herpes Zoster עם שלפוחיות בלחי ימין. מה מכוון לתסמונת Ramsay Hunt?

- א. ירידה בשמיעה באוזן ימין.
- ב. הגבלה בתנועות עיניים.
- ג. תפרחת מפושטת על כל הגוף.
- ד. חולשה בפנים משמאל.

82. בת 26, מניקה תינוק בן 4 חודשים, מועמדת ל-CT עם הזרקת חומר ניגוד. מה ההנחיה הנכונה ביותר לקראת הבדיקה?

- א. ניתן להניק עד הבדיקה אך לאחריה להפסיק הנקה ל-12 שעות.
- ב. אין צורך להפסיק או לדחות הנקה אחרי CT עם הזרקת חומר ניגוד.
- ג. יש לשקול לבצע MRI במקום CT על מנת שלא יהיה צורך להפסיק הנקה.
- ד. יש לדחות את הבירור עד לאחר שתסיים להניק.

83. התקבלו תוצאות מחקר שבדק את הטיפול ב-dual antiplatelet לאחר צנתור קורונרי אלקטיבי והשווה טיפול ב-Clopidogrel יחד עם אספירין אל מול טיפול ב-Prasugrel יחד עם אספירין. המחקר בדק את ה-Primary end-points: תמותה קרדיווסקולרית, Nonfatal MI ו-Nonfatal stroke.



מה ניתן להסיק מהגרף?

- Prasugrel יעיל יותר מ-Clopidogrel בחולי סוכרת מאשר בחולים ללא סוכרת.
- במטופלים מעל גיל 65 Prasugrel יעיל יותר מ-Clopidogrel בהשוואה לצעירים.
- Prasugrel ו-Clopidogrel מועילים במידה שווה בגברים ובנשים.
- התועלת של Prasugrel לעומת Clopidogrel מובהקת יותר בחולים עם תפקוד כלייתי תקין.

84. בת 43, רצת מרתון. מתלוננת על כאבים ורגישות במישוש בשליש הדיסטלי-קדמי של הטיביה. בבדיקה גופנית ללא ממצא חריג למעט רגישות במיקום הנ"ל.

מהו הטיפול היעיל ביותר למצבה?

א. חזרה לפעילות ע"פ סרגל מאמצים מתוכנן, כאב צפוי ולכן לא מכתיב קצב.

ב. הימנעות מדריכה עד שהכאב חולף.

ג. הפסקת ריצה ל-6-8 שבועות.

ד. מתיחות של שרירי התאומים מזרזות החלמה.

85. בת 4 חודשים, נולדה בשבוע 35+1, מהלך הריון ולידה תקינים, בריאה, מחוסנת לגילה. האם שמה לב לגוש במפשעה ימנית. פרט לכך התינוקת מתנהגת כהרגלה, ללא חום, ללא שינוי ביציאות, ללא הקאות.

בדיקה גופנית - ללא חום, סימנים חיוניים תקינים, מצב כללי טוב, בטן רכה ולא רגישה, ללא סימני גירוי צפקי, ללא גושים, ניע תקין. גניטליה נקבית תקינה. במפשעה ימין נמוש גוש בגודל כ-1 ס"מ, רך ולא רגיש, לא פועם, ללא אודם או בצקת, ללא שינוי צבע עור, לא ניתן להחזרה.

מהו הצעד הבא בניהול המקרה?

א. מעקב קליני עוד שבוע.

ב. ניתוח דחוף תוך 48 שעות.

ג. US מפשעות אלקטיבי.

ד. ייעוץ כירורג ילדים תוך שבוע.

86. בת 60, מגיעה לרופא עם תוצאות הבדיקה הבאות:

Test	Result - מהיום	Normal Range
Hemoglobin	10.5	12.5-16 (g/dl)
MCV	106	79-97 fl
Ferritin	51	10-291 (ng/ml)
Transferrin saturation	44%	
Vitamin B12	752	211-911 (pg/ml)
Folic acid	2.1	3.4-5.4 ng/ml (גבולי) >5.4 ng/ml (תקין)

במשטח דם פריפרי נצפו Hypersegmented polymorphonuclear leukocytes.

כיצד יש להתקדם עם המטופלת על מנת לברר את הסיבה למצבה?

א. לברר לגבי צריכה מוגברת של ירקות ירוקים בשבוע טרם ביצוע הבדיקה.

ב. לברר לגבי נטילת טיפול תרופתי ב-Omeprazole.

ג. להשלים בדיקת נוגדנים ל-Anti-intrinsic Factor ו-Antiparietal Cell.

ד. להשלים שאלון CAGE alcohol screening.

87. בת 68, BMI 33, גונת בפנסיה. כאבים בחלק מדיאלי של ברך ימין מספר חודשים, מתגברים בשימוש במדרגות ובמהלך היום, מוקלים על ידי מנוחה. ללא סיפור של חבלה או חום סיסטמי. בבדיקה: ברך חמה, ללא אודם או תפליט, כאבים ביישור וכיפוף של הברך.

בנוסף לפיזיותרפיה, מה יש להמליץ למטופלת להפחתת הכאב ושיפור התפקוד?

א. אקמול פומי ונוגדי דלקת בשימוש מקומי.

ב. סטרואידים סיסטמיים במינון נמוך.

ג. ויטמין D, סידן, ומגה גלופלקס (glucosamine+chondroitin).

ד. הזרקה תוך מפרקית של חומצה היאלורונית.

88. למטופלים הבאים בבדיקת צפיפות עצם T score בעמוד שדרה (-1.5).
את מי יש להפנות לצילום עמוד שדרה צדדי על פי המלצות כוח המשימה הישראלי לקידום בריאות ורפואה מונעת?
- א. גבר בן 75, מעשן.
ב. בת 66 שירדה בגובה 2 ס"מ.
ג. בת 60, מטופלת במשאפי סטרואידים.
ד. בת 65, בעברה שבר ישן בחוליה.
89. מה מאפיין את מהלך רטינופטיה סוכרתית?
- א. במהלך הריון אצל חולת סוכרת נדיר שתפתח רטינופטיה לאור הגנת השינויים ההורמונליים על העין.
ב. הרטינופטיה מתפתחת מהר יותר ובשכיחות גבוהה יותר בסוכרת type 1 מאשר בסוכרת type 2.
ג. השגת יעד איזון של המוגלובין מסוכרר מתחת ל-7% הוכחה המאטה את התפתחות הרטינופטיה בסוכרת type 2, ולא בסוכרת type 1.
ד. לאחר עשר שנים של סוכרת type 2 למרבית החולים תהיה רטינופטיה פרוליפרטיבית.
90. בן שנה וחצי, ברקע - אלרגיה קלה ל-Amoxycillin שהתבטאה בגרד ותפרחת, מחוסן כפי גילו. מזה יומיים חום 38 ומנוזל. בבדיקת אוזן שמאל: הפרשה מוגלתית מהתעלה ללא רגישות בתעלה או מעל הטראגוס (Tragus), לא ניתן לזהות את עור התוף. יתר הבדיקה הגופנית תקינה.
מה הניהול של המטופל בשלב זה על פי ההנחיות הקליניות הישראליות?
- א. Ceforal (Cephalexin) 50 מ"ג/ק"ג למשך 10 ימים ואנלגטיקה.
ב. Zinnat (Cefuroxime) 30 מ"ג/ק"ג/יום למשך 5 ימים ואנלגטיקה.
ג. טיפול מקומי עם מי חמצן 3% ואנלגטיקה. ביקורת רפואית כעבור יממה.
ד. טיפול אנטיביוטי מקומי ב-Ciloxan (Ciprofloxacin) ואנלגטיקה.
91. את מי מהמטופלים הבאים עם נקע בקרסול צריך להפנות לצילום לפי חוקי OTTAWA?
- א. בן 45 עם כאב באיזור המלאולוס המדיאלי ורגישות במישוש קצה המלאולוס.
ב. בת 40 שיכלה לדרוך בזמן הפגיעה אך כעת לא יכולה לדרוך.
ג. בת 50 עם כאב במלאולוס הלטרלי והמדיאלי.
ד. בן 50 עם כאב ונפיחות באיזור המלאולוס הלטרלי.

92. בן 60, ברקע – יתר לחץ דם לא מאוזן, גורמי סיכון קרדיו וסקולריים כולל השמנה, חוסר פעילות גופנית ועישון פעיל. במעקב פסיכיאטרי, נדרש שינוי הטיפול התרופתי.

אילו מבין התרופות הבאות **הכי פחות** סביר שתחמיר את ערכי לחץ הדם של המטופל?

א. Leponex (Clozapine).

ב. Favoxil (Fluvoxamine).

ג. Zyprexa (Olanzapine).

ד. Viepax (Venlafaxine).

93. על פי נייר העמדה לגבי בדיקת נשאות למוטציות BRCA 1/2 מה נכון ביותר?

א. ממחקרים ביהודים בארץ ובעולם מתברר שלפחות מחצית מהמקרים בהם מתגלה נשאות אצל נבדקים,

מדובר באנשים שאין להם סיפור משפחתי משמעותי של ממאירויות.

ב. בחולי/חולות סרטן שד שחלה או לבלב - במידה ולא מתגלה אחת המוטציות השכיחות ניתן להניח כי אין רקע תורשתי לתחלואה.

ג. לנשים בריאות שהן נשאיות לאחת המוטציות מומלצת תכנית מעקב ומניעה מוגברת החל מגיל 40 שהוכח שהיא מקטינה סיכון לתחלואה ותמותה.

ד. הבדיקה באינדיקציה לכל חולי/חולות סרטן שד, שחלות ולבלב ממוצא יהודי-אשכנזי בלבד.

בשאלות הבאות התשובה היא על דרך השלילה:

94. מה מהבאים לא מהווה גורם סיכון להתפתחות סרטן האשך?

א. סרטן באשך קונטרה-לטרלי ל-Cryptorchidism.

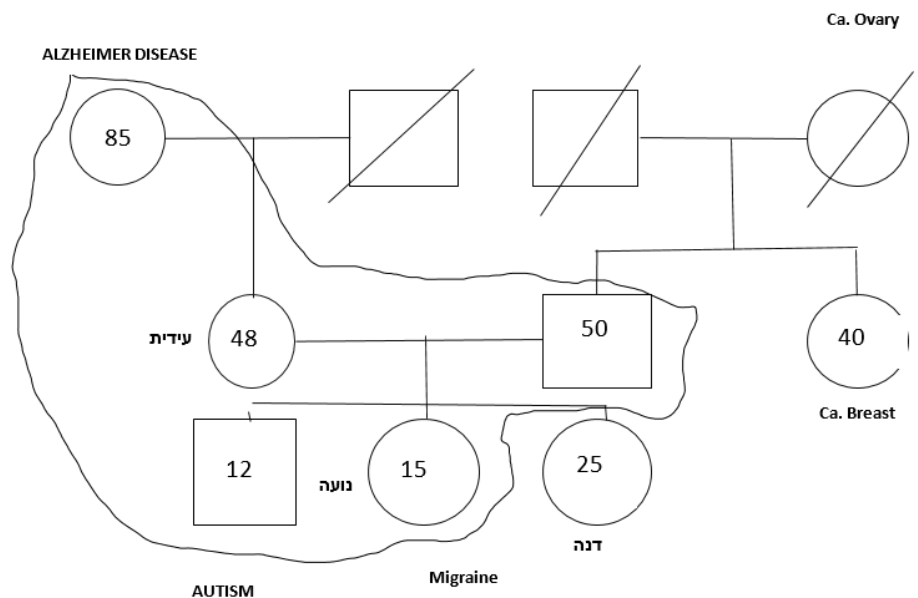
ב. רקע של טראומה לשק האשכים.

ג. סיפור משפחתי דרגה ראשונה של סרטן האשך.

ד. אי פריון גברי.

95. מוצג גנוגרם של משפחת ש.

מה אינה המלצה שניתן לתת על סמך המידע שמוצג בגנוגרם?



א. להפנות את נועה לתמיכה רגשית.

ב. להציע לעידית מסגרות שעוסקות ב-Caregiver burden.

ג. להפנות את עידית ובעלה לטיפול זוגי.

ד. להציע לדנה לבצע ייעוץ גנטי בשאלה של BRCA1,2.

96. בן 3 שנים מגיע למרפאה מלווה באביו המודאג שבנו עונה על הקרטיונים ל-ADHD (Attention deficit hyperactivity disorder), מעוניין בהערכה בנושא.

מה **לא** יכול ההסבר לאב?

א. אבחנה פורמלית של המחלה כוללת הערכה מלפחות שתי מסגרות בהן נמצא הילד, ואפשרית כבר בגיל 4 שנים.

ב. בגילאי גן ויסודי קו טיפול ראשון הוא הדרכת הורים והתערבות בכיתה, ובלא שיפור - תוספת טיפול תרופתי.

ג. גורמי סיכון למחלה כוללים פגות, וכן גורמי סיכון אימהיים כגון צריכת אלכוהול, עישון ולחץ דם מוגבר בהריון.

ד. המשך תסמיני המחלה לבגרות היא סביב ה-40-60%.

97. מה **לא** מאפיין מהלך לאחר ניתוח בריאטרי?

א. מומלצת המתנה של 12-18 חודשים בין הניתוח הבריאטרי עד לכניסה להריון.

ב. תסמונת GERD נדירה לאחר ניתוח שרוול ושכיחה בניתוח מעקף קיבה (Roux-en-Y Gastric Bypass).

ג. ניתוח מעקף קיבה (Roux-en-Y Gastric Bypass) הוא היעיל ביותר מבחינת ירידה במשקל בטווח הרחוק.

ד. לאחר ניתוח בריאטרי מומלצת נטילת ויטמינים ומינרלים לכל החיים.

98. בן 21, מתלונן על הזעה ניכרת בכפות הידיים, מביכה אותו אולם לא מקשה עליו בתפקוד היומיומי.

מה **לא** מתאים לטיפול בבעיה?

א. Tab. Novitropan (Oxybutynin).

ב. שימוש טופיקלי ב-Unhydrol (20% aluminum chloride).

ג. Tab. Ciprallex (Escitalopram).

ד. טיפול מקומי ב-Iontophoresis.

99. בת 62, לוקה בהפרעה דו-קוטבית, מטופלת בליתיום.

מה **לא נכלל** במעקב לנטילת ליתיום?

א. רמת תרופה בדם.

ב. תפקודי כליה ואלקטרוליטים.

ג. תפקודי בלוטת התריס.

ד. תפקודי כבד.

100. בן 30, סובל מאסטמה, מטופל ב-Symbicort (Budesonide/Formoterol) מזה חודש, סובל מכאב גב ולאחרונה החמרה בקוצר נשימה.

אילו מהבאים לא סביר שגרם להחמרה במצבו הנשימתי?

א. שימוש יתר ב-Ventolin (Salbutamol).

ב. נטילת Etopan (Etodolac) 500 mg.

ג. טיפול ב-Omepradex (Omeprazole) 20 mg.

ד. טיפול ב-Aspirin.

בהצלחה!